← Article

박수홍
@parkhongsu

1만 2천 1천 1만

CMS.gov CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES

Newsroom Home All

Home > Newsroom > Newsroom > RSS Feed > CMS Proposes 2027 Medicare Advantage and Part D Payment Notice

Tweet 0 0.00 0.00

CMS Proposes 2027 Medicare Advantage and

← Article

Medicare Advantage Medicare Part D Medicare Part C Home

Share

CMS Proposes 2027 Medicare Advantage and Part D Payment Notice to Improve Access and Administration

기업 CMS가 2027년 메디케어 파트 C(메디케어 어드밴티지) 및 파트 D(처방약 보험) 지급 규칙을 제안했다.

전년 대비 0.4% 인상.

가독성이 떨어지지.

관련 보도 보면 전자는 처방약 실적보다 높은데,

의료 서비스 불가능 도시로는, 정부가 보험에서 주는 돈은 그대로다.

같은 날, 유나이티드헬스 대표 퇴직 소식도 전해졌다. 관련은 홈페이지 상당 적으로 바뀐다.

왜 같은 보험이 전자로 변하는 것일까?

Part 1: 보험사가 돈을 버는 구조

정부 위탁 보험의 메커니즘

← Article

정부가 보험사에 돈을 준다. 보험사는 그 돈으로 노인들의 의료비를 감당한다.

정부가 주는 돈을 "미리받기"라고 부른다. 미리 돈 보면 보험사 마이너 놓아요 이 상태로 끝이다.

간단하다.

정부가 계산해 놓았다.

보험사 메디케어 월급이 있다.

개인 정부가 인구 데이터를 보고 계산한다. 이 사람 의료비 얼마 지출할 것이다, 이 사람은 돈 많이 쓰겠다.

정부가 한 명 한 명 "미리받기"라고 부른다. 미리 돈 보면 보험사 마이너 놓아요 이 상태로 끝이다.

보험사는 그 돈으로 노인들의 의료비를 대신 내준다.

리스크 조정이라는 게임

정부는 환자마다 다른 금액을 준다.

건강한 80대한테는 적게 준다. 심각 노인 당뇨 치매한테는 많이 준다. 정 환자에게 가장 많이 준다.

← Article

그러면 왜 이게 문제가 되나.

일부 보험사는 일부러 나쁜 환자만 모으기 위해 애쓰고 있다.

당뇨 치료를 잘하면 정부가 돈을 더 준다. 그렇지만 돈을 주기만큼 두 다리 건강하게 만들어 놓는다.

일부 보험사 입장 자리 전문 의사 고용하고 의료 서비스 제공한다.

보험사 그 안 안에는 인간 있다는 게 문제다. 의료진 자기 이익이 정부 이익과 충돌한다.

← Article

그러면 정부는 뭐 하나.

정부도 알고 있다. 그래서 2026년부터 리스크 조정 산정 방식이 달라진다.

주요 변경 사항

일부 질환 하위 범주에 연결되지 않은 코드는 산정에서 빠진다는 뜻이다.

정부가 억지로 기운 빼는 일들 같다. 돈 주기는 싫은 거지 정말 그렇다.

일부 보험 부문 적자 크게 보고, 리스크 정산 금액 감소 예상된다.

리스크 자체 하락 전망 인한 보고 비용이 늘어나 보험사들이 돈 벌기 어려워진다.

이게 가장 큰 변화다.

정부 정책만 바뀌는 게 아니다. 의료 시장 자체가 통째로 흔들리고 있다.

보험사 입장에서 이게 왜 치명적인지 이해하려면 먼저 이 용어부터 알아야 한다.

MLR.

의료비 분모 대비 의료비 분자 비율이다.

의료비 분자는 의료 제공에 들어간 돈이다. 의사 진료, 검사, 입원, 약값 전부 다.

분모는 보험료 수입이다. 사람들이 보험사에 내는 돈.

MLR 80%라는 게 무슨 뜻이냐면, 보험사가 보험료 100원 받으면 의료비 80원 쓰는 구조다.

나머지 20원은 사람 인건비, 광고비, 본사 건물 유지비, 주주 배당금 전부 여기서 나온다. 그게 이번 정부 개혁안에 들어가는 핵심 단어다.

MLR 85%로 올리는 것.

선한의 그 구조

← Article

본 문 보충이다.

이 구조 자체만은 고급 병원 이용자 혜택이다. 병원 입장은 억울하게 보면 공정하다.

선한은 지역 병원과 직접 계약이 없다. 공동 의료 시설이 대부분이다. 이게 의료 비용 대비 고급 서비스 제공하는 방식이 일반 보험 같지만 다르다.

이런 구조에서는,

- 고급 의료 인프라 구축
- 자체 진료팀 정액 인센티브 보장

그렇지만 대형 노동 방식에 적용 시 메디케어 의료비 지출 보험 사보다 적게 받는다.

- 전화 상담 제공하지 않음.

가입자 특성 고려한 세분화 불가능 이건 구조.

일부 보험사, 의료 서비스 제공 대신 현금 지급 방식 도입 시도 중이다. 이게 가장 큰 변화다. 진료 대신 돈 주는 방식.

이게 성공하면 기존 의료 시스템 자체가 흔들린다. 이게 실패하면 의료 서비스 제공 자체가 사라진다.

선한의 고급 구조

← Article

이 구조 자체만은 고급 병원 이용자 혜택이다. 병원 입장은 억울하게 보면 공정하다.

선한은 지역 병원과 직접 계약이 없다. 공동 의료 시설이 대부분이다. 이게 의료 비용 대비 고급 서비스 제공하는 방식이 일반 보험 같지만 다르다.

이런 구조에서는,

- 고급 의료 인프라 구축
- 자체 진료팀 정액 인센티브 보장

그렇지만 대형 노동 방식에 적용 시 메디케어 의료비 지출 보험 사보다 적게 받는다.

- 전화 상담 제공하지 않음.

가입자 특성 고려한 세분화 불가능 이건 구조.

일부 보험사, 의료 서비스 제공 대신 현금 지급 방식 도입 시도 중이다. 이게 가장 큰 변화다. 진료 대신 돈 주는 방식.

이게 성공하면 기존 의료 시스템 자체가 흔들린다. 이게 실패하면 의료 서비스 제공 자체가 사라진다.

그렇지만 정부 입장에서는 이게 오히려 위험하다.

MLR 85%가 최종 답이 아닌 이유

← Article

보험사가 이기는 방법 세 가지다. 정부가 싫어하는.

첫째, 환자가 정말 필요한 의료 서비스 제공하지 않는다. 의료 서비스 제공 줄이면 분모 올라가 MLR 떨어진다. 이게 가장 흔한 방법이다. 정부 입장에서 이게 가장 나쁘다. 환자 고통 발생한다.

둘째, 불필요한 검사를 더 많이 한다. 의료 서비스 양 늘리면 분자 올라가 MLR 올라간다. 이게 가장 흔한 방법이다. 의료진 입장에서 불편한 것 많다. 이게 의료 현장 사기 떨어진다.

셋째, 의료 품질 높은 사람만 가입하게 한다. 아픈 사람들이 보험사 밖으로 밀려난다. 이게 가장 나쁘다. 이게 사회 전체 문제다.

이게 다른 보험사 시장 점유율 떨어진다는 이야기다.

문나를 지금 이게 가장 위험한 게 이것이다. 의료 서비스 제공 줄이고 돈 벌기 위해 환자 고통 발생시키는 보험사가 늘어나는 구조.

그렇지만 정부 입장에서는 이게 오히려 위험하다. 이게 가장 나쁜 방법이다. 이게 가장 위험한 게 이것이다. 의료 서비스 제공 줄이고 돈 벌기 위해 환자 고통 발생시키는 보험사가 늘어나는 구조.

그렇지만 정부 입장에서는 이게 오히려 위험하다. 이게 가장 나쁜 방법이다. 이게 가장 위험한 게 이것이다.

그래서 정부는 MLR 85% 최종 답이 아니라고 말하고 있다.

← Article

- 의료 서비스 제공하지 않는 방법 다른 것.
- 정부한테 이게 가장 안 좋다.

관리한 의료비 지출 대비 의료 서비스 제공 비율 이다.

관리한 의료비 지출 대비 의료 서비스 제공 비율 이다.

관리한 의료비 지출 대비 의료 서비스 제공 비율 이다.

- 의료 서비스 제공 줄이면 분모 올라가 MLR 떨어진다. 이게 가장 흔한 방법이다. 정부 입장에서 이게 가장 나쁘다. 환자 고통 발생한다.
- 불필요한 검사 많이 하면 분자 올라가 MLR 올라간다. 이게 가장 흔한 방법이다. 의료진 입장에서 불편한 것 많다. 이게 의료 현장 사기 떨어진다.
- 아픈 사람들 밀어내면 MLR 떨어진다. 이게 가장 나쁜 방법이다. 이게 가장 위험한 게 이것이다. 의료 서비스 제공 줄이고 돈 벌기 위해 환자 고통 발생시키는 보험사가 늘어나는 구조.

그래서 정부는 MLR 85% 최종 답이 아니라고 말하고 있다.

Part 2: 유나헬스 센텐은 뭐가 다른가

센텐 유나헬스 경쟁자 중 센텐이 가장 독특하다.

이유는

← Article

- 센텐이 가장 독특한 이유 (Centene Corporation)
- 주요 특징 중 일부만 (MCO)
- 주요 고객이 정부 입니다 (Medicaid)

정부한테만 의존을 넘어.

- 유나헬스 메디케어 어드밴티지 중심인 고령자 보험사
- 센텐 메디케이드 중심인 저소득층 보험사

이 고객 구조 자체가 비슷해 구조적 차이로 이어진다.

유나헬스의 고객 구조

유나이티드헬스 대표는 메디케어 어드밴티지 사업자다. 주 고객은 고령자다. 보험료도 소득 기준 있다.

← Article

보험사 입장에서 이게 왜 중요한지 이해하려면, **리인슈어 overload** 개념부터 알아야 한다. 보험 인수하다 가입자 많아지면, 최악 기록을 감당할 수 있는 보험사만 살아남는다. 이게 **Medicare Advantage** 시장 전체 구조를 결정하는 게임이다.

이는 관점을 달리하는 수학 방정식이라고 하는데, 세분화 될 경우 구조를 놓치는 경향 인식 보호 인인을 가정합니다.

2027년부터 이게 바뀐다.

이게 단순히 숫자 게임이다. 보험사 입장에서 메디케어 어드밴티지 중심 보험사는 이게 단순해 게 아니다. 정부한테 돈 받는 보험사는 이게 가장 위험하다. 이게 가장 위험한 게 이것이다.

센텐의 고객 구조

← Article

본 문 보충이다.

이 구조 자체만은 고급 병원 이용자 혜택이다. 병원 입장은 억울하게 보면 공정하다.

센텐은 지역 병원과 직접 계약이 없다. 공동 의료 시설이 대부분이다. 이게 의료 비용 대비 고급 서비스 제공하는 방식이 일반 보험 같지만 다르다.

이런 구조에서는,

- 고급 의료 인프라 구축
- 자체 진료팀 정액 인센티브 보장

그렇지만 대형 노동 방식에 적용 시 메디케어 의료비 지출 보험 사보다 적게 받는다.

- 전화 상담 제공하지 않음.

가입자 특성 고려한 세분화 불가능 이건 구조.

일부 보험사, 의료 서비스 제공 대신 현금 지급 방식 도입 시도 중이다. 이게 가장 큰 변화다. 진료 대신 돈 주는 방식.

이게 성공하면 기존 의료 시스템 자체가 흔들린다. 이게 실패하면 의료 서비스 제공 자체가 사라진다.

그렇지만 정부 입장에서는 이게 오히려 위험하다. 이게 가장 나쁜 방법이다. 이게 가장 위험한 게 이것이다. 의료 서비스 제공 줄이고 돈 벌기 위해 환자 고통 발생시키는 보험사가 늘어나는 구조.

그렇지만 정부 입장에서는 이게 오히려 위험하다. 이게 가장 나쁜 방법이다. 이게 가장 위험한 게 이것이다.

그래서 정부는 MLR 85% 최종 답이 아니라고 말하고 있다.

← Article

- 의료 서비스 제공하지 않는 방법 다른 것.
- 정부한테 이게 가장 안 좋다.

관리한 의료비 지출 대비 의료 서비스 제공 비율 이다.

관리한 의료비 지출 대비 의료 서비스 제공 비율 이다.

관리한 의료비 지출 대비 의료 서비스 제공 비율 이다.

- 의료 서비스 제공 줄이면 분모 올라가 MLR 떨어진다. 이게 가장 흔한 방법이다. 정부 입장에서 이게 가장 나쁘다. 환자 고통 발생한다.
- 불필요한 검사 많이 하면 분자 올라가 MLR 올라간다. 이게 가장 흔한 방법이다. 의료진 입장에서 불편한 것 많다. 이게 의료 현장 사기 떨어진다.
- 아픈 사람들 밀어내면 MLR 떨어진다. 이게 가장 나쁜 방법이다. 이게 가장 위험한 게 이것이다. 의료 서비스 제공 줄이고 돈 벌기 위해 환자 고통 발생시키는 보험사가 늘어나는 구조.

그래서 정부는 MLR 85% 최종 답이 아니라고 말하고 있다.

Duck 9- 세대의 서태

← Article

정부는 환자 한 명 기준 돈 준다.

센텐은 2026년에도 메디케이드 보험사로 가장 큰 고객을 가졌다. 이게 가장 큰 고객이다.

메디케이드는 메디케어보다 훨씬 소득 기준 있다. 가난한 사람들 대상 보험이다. 이게 가장 큰 고객이다.

이게 왜 중요하냐면, 정부 돈이 한 명 기준 정해져 있다. 이게 가장 큰 고객이다.

2027년 정책 변화를 알고 있었을까? 아니오 한 문장이다.

← Article

2027년 정책 변화를 알고 있었을까? 아니오 한 문장이다.

선한의 갈등과 의정

선한의 메디케이드 보험사 대표 제임스 월튼이 이번 주 의회 증언에 나왔다. 이게 가장 큰 고객이다.

이게 왜 중요하냐면, 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다.

의사들이 화났다.

2027년 정책 변화를 알고 있었을까? 아니오 한 문장이다.

← Article

2027년 정책 변화를 알고 있었을까? 아니오 한 문장이다.

선한의 의정 갈등

선한의 메디케이드 보험사 대표 제임스 월튼이 이번 주 의회 증언에 나왔다.

의사들이 화났다. 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다.

이게 왜 중요하냐면, 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다.

Duck 9- 세대의 서태

← Article

정부는 환자 한 명 기준 돈 준다.

센텐은 2026년에도 메디케이드 보험사로 가장 큰 고객을 가졌다. 이게 가장 큰 고객이다.

메디케이드는 메디케어보다 훨씬 소득 기준 있다. 가난한 사람들 대상 보험이다. 이게 가장 큰 고객이다.

이게 왜 중요하냐면, 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다.

2027년 정책 변화를 알고 있었을까? 아니오 한 문장이다.

← Article

2027년 정책 변화를 알고 있었을까? 아니오 한 문장이다.

1월 26일 발표된 "사전 공지"다.

전문 이슬홍의 4월 6일 전문에 나왔다.

CMS가 2월 2일자로 이 초안을 공개했다.

보통 의견 수렴 기간은 60일이다. 한 주 만에 끝나는 게 이례적이다.

"기존 지침 개정일 나만 갑자기 적용"이라는 "기존 지침 개정일 나만" 같은 조항을 없앴다.

CMS가 내놓은 일부 변경이다.

이게 왜 문제냐면, 이게 가장 큰 변화다. 이게 가장 큰 변화다. 이게 가장 큰 변화다.

보험사들이 반발했다. 이게 가장 큰 변화다. 이게 가장 큰 변화다. 이게 가장 큰 변화다.

이게 왜 중요하냐면, 이게 가장 큰 변화다. 이게 가장 큰 변화다. 이게 가장 큰 변화다.

이 정책이 알려진 것

2027년 메디케이드 보험사 대표 제임스 월튼이 이번 주 의회 증언에 나왔다.

의사들이 화났다. 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다.

이게 왜 중요하냐면, 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다.

이게 의료비 지출 증가는 2월 이후 2주 만에 공개되었다. 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다.

그러면 놓아요 이 상태로 끝이다.

이게 왜 중요하냐면, 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다. 이게 가장 큰 고객이다.

이게 의료비 지출 증가는 2월 이후 2주 만에 공개되었다.